



كلية الطب بصفاقس
Faculté de médecine de Sfax

Les céphalées

Pr. Nouha FARHAT, Pr Ag Sawsan DAOUD
Service de Neurologie, CHU Habib Bourguiba , Sfax
nouha.farhat15@gmail.com

Année universitaire: 2024-2025

Objectifs

1. Expliquer la physiopathologie de la migraine.
2. Etablir la démarche diagnostique (positive, différentielle et étiologique) devant une céphalée **récente** **primaire** et **secondaire**.
3. Etablir la démarche diagnostique (positive, différentielle et étiologique) devant une céphalée **chronique** **primaire** et **secondaire**
4. Poser le diagnostic d'une **urgence** devant des céphalées
5. Etablir, à partir des données cliniques, le diagnostic d'une **migraine**.
6. Etablir à partir des données cliniques, le diagnostic d'une **céphalée de tension**, d'une **névralgie du trijumeau** et d'une **algie vasculaire de la face**

Brutale

- Maximale **en moins 1 heure**
- **Coup de tonnerre** en intensité maximale avec un EVA>7 en **moins d'une minute**
- **Faire attention aux urgences**

Hémorragie méningée: 10-30%

HTIC aiguë

Causes vasculaires

Glaucome aigu à angle fermé

Sinusite aiguë

Subaiguës d'aggravation progressive

- Quelques jours

Méningite subaiguë

méningoencéphalite

HTIC subaiguë

Maladie de Horton

Céphalée chronique

- **Mois ou des années**
- **Secondaire**
- **Primaire:**
 - Sans lésion sous-jacente
 - épisodique

Brutale

- Maximale **en 1 heure**
- **Coup de tonnerre** en intensité maximale avec un EVA>7 en **moins d'une minute**

Hémorragie méningée
HTIC aiguë
Causes vasculaires
Glaucome aigu à angle fermé
Sinusite aiguë

- Quelques jours

Méningite subaiguë
méningoencéphalite
HTIC subaiguë
Maladie de Horton

- Mois ou des années
- Secondaire
- Primaire:
 - Sans lésion sous-jacente
 - Paroxystique

Hémorragie méningée

- **Urgence diagnostique et thérapeutique**
- Céphalée d'apparition « explosive » (**en « coup de tonnerre »**),
- Syndrome méningé **subfébrile**

Scanner cérébral sans injection

- **Hyperdensité spontanée** dans les espaces sous-arachnoïdiens

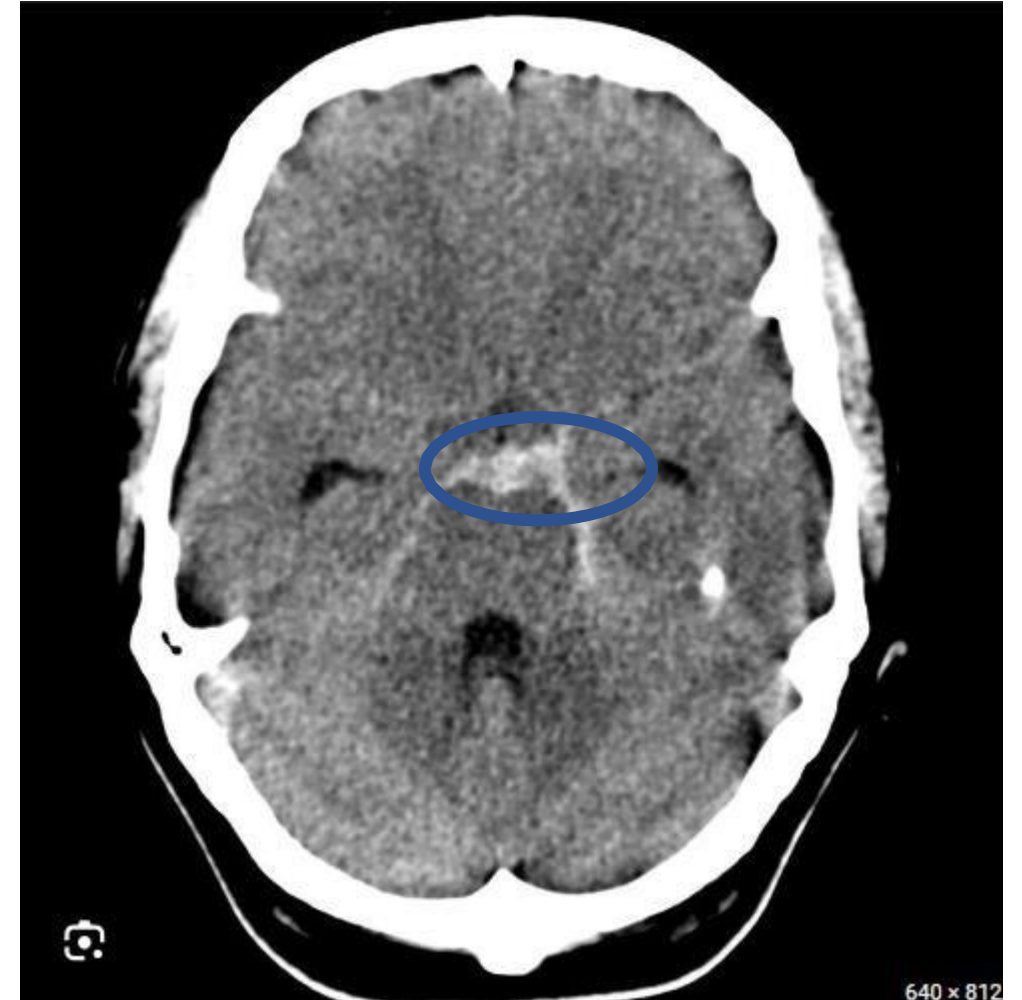
L'IRM (séquences FLAIR et T2* écho de gradient)

- Plus sensible

- Même si **l'imagerie cérébrale normale** : ponction lombaire : xanthochromie (pigments biliaires)

Hémorragie méningée

- Anévrisme rompu dans 80 % des cas
- Les principales complications
 - Vasospasme
 - Resaignement
 - Hydrocéphalie



Accidents vasculaires cérébraux

- Hématome et infarctus cérébraux
 - hématome intra- parenchymateux (surtout de localisation cérébelleuse)
 - Déficit focal++++
- Dissection artérielle
 - 50 à 70% (Les céphalées sont le symptôme le plus fréquent)
 - Signes associés : un syndrome **de CBH**, à un déficit d'un ou plusieurs nerfs crâniens (**IX, X, XI, XII**) et/ou des acouphènes pulsatiles

Dissection artérielle

- **Céphalées :**
 - Ipsilatérales à la dissection, de topographie faciale, rétro-orbitaire, temporale ou occipitale, tensives ou pulsatiles, constantes, **sévères** rarement brutale
- **Topographie**
 - **Antérieure** dans les dissections carotidiennes
 - **Postérieure** associées à des cervicalgies dans les dissections vertébrales

Dissection artérielle

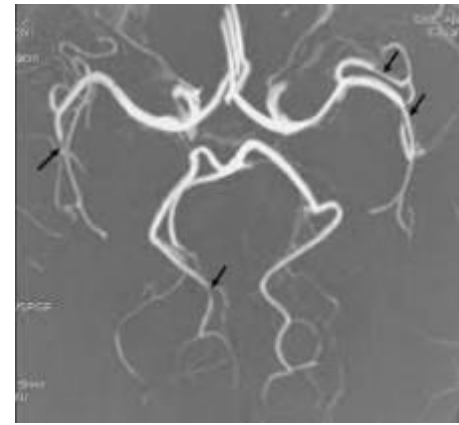
- **Dissection artérielle**

- échodoppler et surtout **l'angioscanner et l'IRM cervicale** (avec angio-IRM et coupes cervicales) permettent le diagnostic en visualisant un **rétrécissement artériel avec un hématome de la paroi**



Case courtesy of Dr Devanshi Dharaiya, Radiopaedia.org, rID: 30889

Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible



- Céphalée isolée
- a **début brutal** durant **quelques minutes à quelques heures**
- se répétant sur quelques jours à un mois
- **spontanés ou favorisés** par l'effort physique, l'exposition à des substances vasoactives ou le contexte du post partum
- TDM, PL sont normaux
- **l'IRM ave ARM cérébrale:** rétrécissements et des dilatations des artères cérébrales réversible en 1-3 mois

Autres

- Glaucome à angle fermé
- Sinusite aiguë
 - Céphalée frontale
 - Pression des régions sinusiennes majore la douleur + écoulement purulent nasal
 - Scanner des sinus

Brutale

- Maximale en 1 heure
- Coup de tonnerre en intensité maximale avec un EVA > 7 en moins d'une minute

Hémorragie méningée
HTIC aiguë
Causes vasculaires
Glaucome aigu à angle fermé
Sinusite aiguë

Récente d'aggravation progressive

- Quelques jours

Méningite subaiguë
méningoencéphalite
HTIC subaiguë
Maladie de Horton

Céphalée chronique

- Mois ou des années
- Secondaire
- Primaire:
 - Sans lésion sous-jacente
 - Paroxystique

Méningite et méningoencéphalite

- Méningite : syndrome méningé fébrile : PL après scanner ++
- Méningoencéphalite : les **signes neurologiques focaux**, les crises épileptiques et les troubles de la vigilance
 - Méningoencéphalite lymphocytaire: PCR Herpes++++
 - traitement antiherpétique (acyclovir)

Hypertension intracrânienne subaiguë

- Excès de synthèse
- Augmentation de la masse cérébrale (œdème, processus expansif intracérébral)
- Défaut de résorption, notamment par blocage de circulation
- Origine vasculaire (thrombose veineuse cérébrale)

Céphalées (HTIC)

Diffuses, « en casque »

- Souvent intenses, atroces (broiement, éclatement, ...),
- Réveillant **la nuit**,
notamment au petit matin,
- Accrues **par le moindre effort** (marche, rotation de la tête, toux)

• **Aggravées par la position couchée**

• Des vomissements

- Typiquement « en jet », au paroxysme de la céphalée
- **Améliorent les céphalées**
- Mais inconstants (parfois seulement des nausées)

• Troubles visuels

- Impression **de flou** bilatérale
- Avec parfois des « **éclipses visuelles** »
- Une diplopie par atteinte du **VI** (long et fragile): non localisatrice
- **Un œdème papillaire au fond d'œil**

1. Thrombose veineuse cérébrale

- Récente et progressive, est quasi constante. Un début brutal peut se voir.
- signes focaux **bilatéraux** et à **bascule** sont évocateurs du diagnostic
- Même que **le contexte** (*postpartum...*)
- infarctus **veineux ou hémorragique** (**hétérogène ++**)
- IRM cérébrale avec ARM veineuse
- **Traitement anticoagulant doit être instauré en urgence même en cas de suffusion hémorragique**

2. Processus expansif intracrânien

- Céphalée récente souvent **progressive**
- Signe HTIC+ **signe de localisation**
- L'IRM ou le scanner (**avec injection** de produit de contraste)

3. Hypertension intracrânienne idiopathique

- Diagnostic d'élimination
- Contexte est souvent évocateur (**jeune femme obèse**, prise de corticoïdes, vitamine A)
- La ponction lombaire avec prise de pression (réalisée après imagerie) +++

Maladie de Horton (artérite gigantocellulaire)

- Plus de 50 ans+++
- Les manifestations de la maladie de Horton peuvent être classées en 4 grandes catégories+++ (à retenir)
 - Syndrome céphaliques
 - Signes ophtalmologiques
 - Syndrome rhumatismal
 - Signes généraux
- Aucun signe n'est constant et chacun peut révéler la maladie.

Maladie de Horton (artérite gigantocellulaire)

- Signes locaux et généraux :
 - Artère temporale indurée douloureuse et non pulsatile
 - Altération de l'état général
 - Pseudopolyarthrite rhizomélique (association dans 50 % des cas),
 - Épisodes de **cécité monoculaire transitoire** (qui annoncent l'imminence d'une cécité définitive)
 - Infarctus cérébraux, claudication de la mâchoire

Maladie de Horton (artérite gigantocellulaire)

- Élévation de la VS et de la CRP ; profil inflammatoire à l'EPP....
- Écho-doppler
- artérite gigantocellulaire à la **biopsie de l'artère temporale++++**
- corticothérapie urgente

Brutale

- Maximale en 1 heure
- Coup de tonnerre en intensité maximale avec un EVA > 7 en moins d'une minute

Hémorragie méningée
HTIC aiguë
Causes vasculaires
Glaucome aigu à angle fermé
Sinusite aiguë

Subaiguës d'aggravation progressive

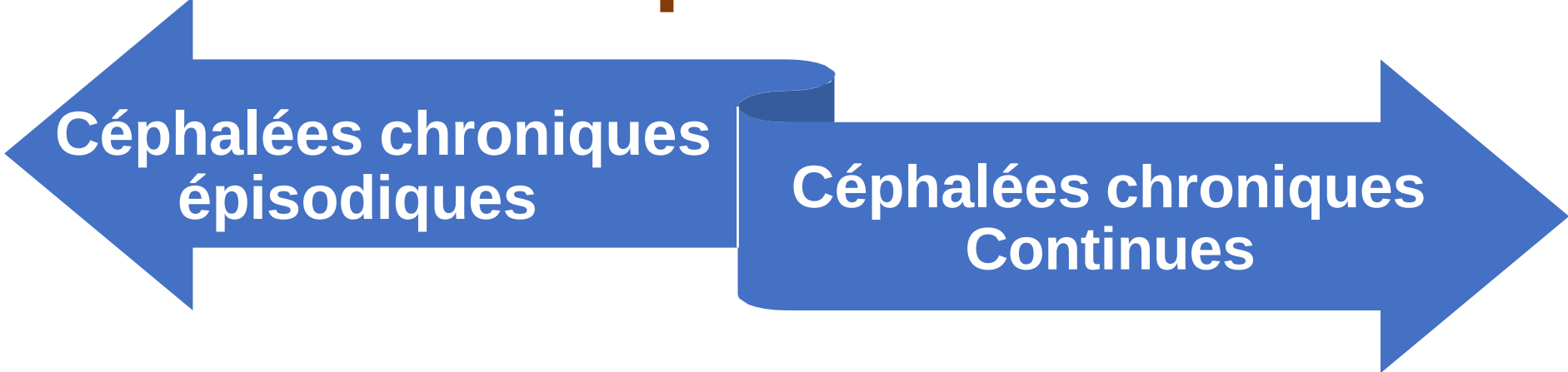
- Quelques jours

Méningite subaiguë
méningoencéphalite
HTIC subaiguë
Maladie de Horton

Céphalée chronique

- Mois ou des années
- Secondaire
- Primaire:
 - Sans lésion sous-jacente

Céphalées chroniques



Céphalées chroniques
épisodiques

Céphalées chroniques
Continues

- **Primaires**

- Migraine (la plus fréquente)
- Algie vasculaire de la face
- Névralgie du trijumeau

- **Secondaires**

- Malformation artérioveineuse
- Phéochromocytome

- **Primaires**

- Céphalées dites de tension (psychogènes)
- Céphalées post-traumatiques
- Céphalées par abus d'antalgiques
- Cervicalgies chroniques

- **Secondaires**

- Céphalées d'origine diverse
- Tumorale

POSER LE DIAGNOSTIC D'UNE URGENCE DEVANT DES CEPHALEES

Drapeaux rouges:

- Interrogatoire :
- Age > 50 ans
- Existence néoplasie sous-jacente, HTA, HIV, maladie de système
- Céphalée **récente et d'installation rapidement progressive**
- Céphalée **récente et d'installation brutale**
- Céphalée **inhabituelle** chez un céphalalgique connu
- Céphalée + **signe neurologique**
- Céphalée + **signes généraux** (fièvre, VS augmentée, AEG)
- Céphalée **suite** accouchement, traumatisme crânien, poncturale.

POSER LE DIAGNOSTIC D'UNE URGENCE DEVANT DES CEPHALEES

Drapeaux rouges:

-Examen clinique :

à Examen neurologique :

Signes de localisation Signes méningés, Syndrome confusionnel

à Examen du segment céphalique :

Artères temporales faibles et indurées

Rougeur oculaire

Auscultation cervicale et crânienne: Souffle

Douleurs sinusiennes et dentaires

Douleurs à la palpation du rachis cervical

à Examen général :

Fièvre

Chiffres tensionnels élevés

Migraine

- Cause la plus fréquente
- Femme
- Avant 40 ans
- Interrogatoire et la normalité de l'examen clinique
- **Aucune investigation complémentaire n'est nécessaire lorsque la sémiologie est typique**
- **Critères diagnostiques selon la classification de *l'International Headache Society* ICHD 3+++**

Migraine avec aura

- *Signes neurologiques* **focalisés** (le plus souvent « **positifs** »)
- Critères de l'aura+++
- **Précédant ou accompagnant** la céphalée migraineuse et classiquement controlatérale
- Progressive ≥ 5 minutes, régression complète en moins **d'une heure** avant ou parallèlement à la céphalée
- *Scotome scintillant* est **le plus fréquent** des symptômes visuels
- **auras atypiques+++** doivent conduire à des examens complémentaires (**IRM cérébrale**)
- Migraine avec aura : Critères diagnostiques selon la classification de *l'International Headache Society* ICHD 3 (2018)+++

Algie vasculaire de la face

- Diagnostic repose sur l'interrogatoire
- **Souvent nécessaire** de réaliser **une imagerie** devant tout doute diagnostic pour éliminer une autre affection, notamment une **dissection carotide** (en cas de syndrome de **Claude Bernard-Horner douloureux**)

Algie vasculaire de la face

Homme jeune (20 à 40 ans)

Crises douloureuses stéréotypées, parfois déclenchées par la **prise d'alcool**.

Douleur :

maximale **en quelques minutes**

localisation ***strictement unilatérale***

périorbitaires

durant ***15 à 180 minutes***

Manifestations neurovégétatives (parasympathiques) **homolatérales** :

larmoiement, congestion nasale, sudation cutanée ; syndrome de Claude Bernard- Horner.

Algie vasculaire de la face

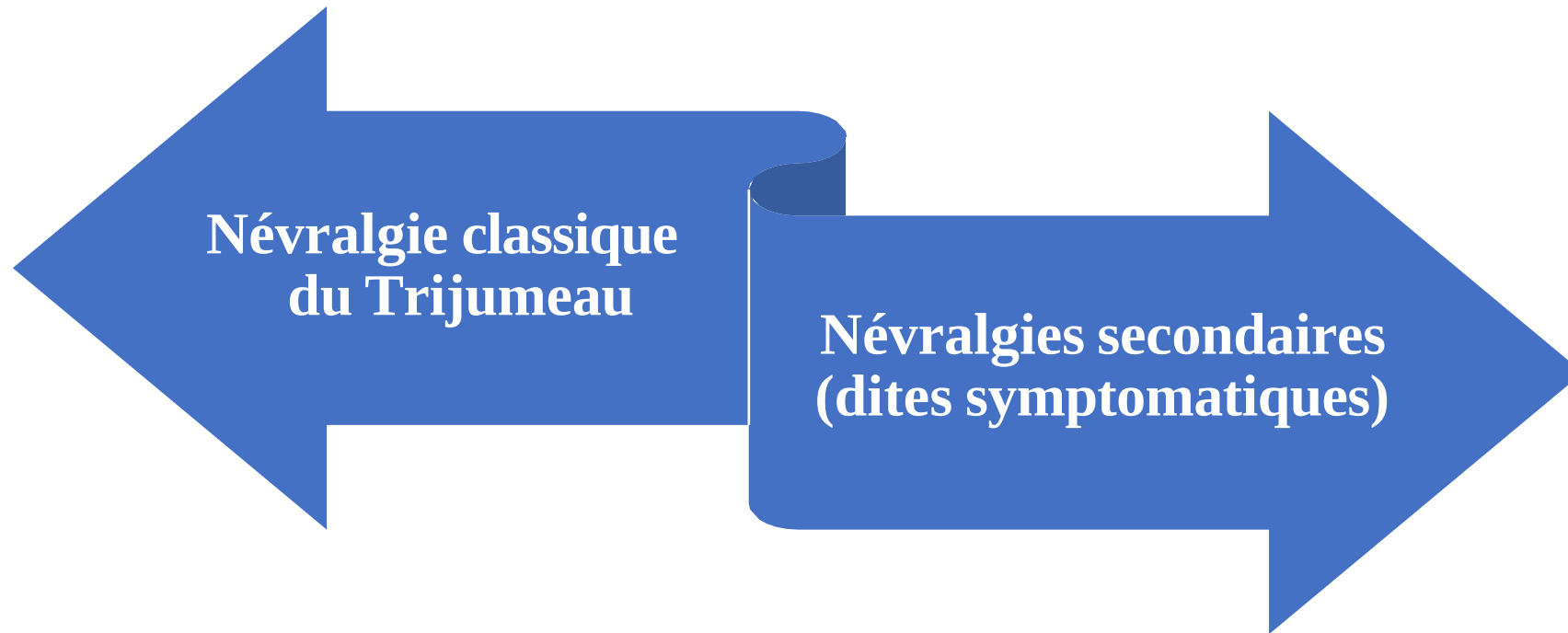
Mode évolutif :

Plusieurs crises **quotidiennes** (une à huit ; deux à trois en moyenne) ;

*périodes de crises quotidiennes durant de **2 à 8 semaines**, volontiers **saisonniers**, algie vasculaire de la face **épisode***

Névralgies du Trijumeau

- *Le diagnostic est purement clinique*



Névralgie CLASSIQUE du Trijumeau (nerf V)

- **Femme après 50 ans**
- Sièges : toujours *unilatéral*, touchant la branche **V2 (40 %)**, **V3 (20 %)**, exceptionnellement V1 (10 %), parfois deux branches (comportant la V2), **jamais les trois.**
- Type : **décharges électriques fulgurantes, de durée très brève** (quelques **secondes**)
Évolution : **en salves sur quelques minutes** séparées par des **intervalles libres** de toute douleur, se répétant plusieurs fois par jour pendant quelques jours à semaines.

Névralgie classique du Trijumeau (nerf V)

Mode de déclenchement

- Spontané. Ou lors *d'activités spécifiques repérées* par le patient (ouverture de la bouche, mastication, etc.) ou par **simple effleurement d'une zone cutanée ou muqueuse limitée (dite « zone gâchette »)**

Examen clinique

- Il est par définition ***normal*** dans la névralgie « classique »
- La moindre anomalie de l'examen clinique impose la réalisation **d'une IRM cérébrale:** (conflit vasculo-nerveux)

Névralgies secondaires (dites symptomatiques)

- Douleur moins intense
- Douleur dans le territoire du **V1**
- Persistance d'un fond douloureux entre les accès
- **Anomalies à l'examen clinique** : hypoesthésie, V3 moteur (masséters, ptérygoïdiens), atteinte d'autres nerfs crâniens ou autres signes de localisation

Céphalée de tension, dite « psychogène »

- Elle est **chronique** et souvent **permanente**
- *céphalée diffuse*, prédominant au vertex ou dans les régions **cervico-occipitales**
- Aggravation *en périodes **de tension psychologique**, de fatigue*
- L'examen clinique peut révéler des douleurs à la palpation des muscles cervicaux paravertébraux et des trapèzes.
- L'examen neuro est **sans anomalies**.

Conclusion

1. Classer selon mode d'évolution et signes de l'examen clinique
2. Éliminer les causes secondaires traitables: les drapeaux rouges de céphalées primaires
3. **Urgences** : hémorragie méningée, AVC, Dissection artérielle, méningite, méningoencéphalite, thrombophlébite cérébrale
4. **Critères diagnostiques cliniques**
 1. **Migraine avec et sans aura**
 2. **Névralgie du trijumeau**
 3. **Algie vasculaire de la face**

1. Les caractéristiques d'une migraine sont

- A. Douleur bilatérale
- B. Douleur du cuir de chevelu
- C. Douleur résistante aux antalgiques
- D. Accompagnés parfois de signes vasomoteurs
- E. Récupération complète après la crise

Les caractéristiques d'une migraine sont:

- A. Douleur bilatérale
- B. Douleur du cuir de chevelu
- C. Douleur résistante aux antalgiques
- D. Accompagnés parfois de signes vasomoteurs**
- E. Récupération complète après la crise**

2. Les Auras typiques

A. Aura Visuelle

B. Aura Sensitive

C. Aura Phasique

D. Aura Hémiplégique

E. Aura Rétinienne

Les Auras typiques

A. Aura Visuelle

B. Aura Sensitive

C. Aura Phasique

D. Aura Hémiplégique

E. Aura Rétinienne

3. La durée habituelle d'une crise de migraine sans traitement est

- A. Moins de 30 minutes
- B. 1 à 2 heures
- C. Entre 4 et 72 heures
- D. Plus d'une semaine
- E. Entre 15 et 30 minutes

La durée habituelle d'une crise de migraine sans traitement est

- A. Moins de 30 minutes
- B. 1 à 2 heures
- C. Entre 4 et 72 heures**
- D. Plus d'une semaine
- E. Entre 15 et 30 minutes

4. Quel symptôme peut précéder la migraine (appelé aura) est :

- A. Nausées uniquement
- B. Toux sèche
- C. Troubles visuels comme des éclairs lumineux
- D. Démangeaisons
- E. Manque du mot

Quel symptôme peut précéder la migraine (appelé aura) est :

- A. Nausées uniquement
- B. Toux sèche
- C. Troubles visuels comme des éclairs lumineux**
- D. Démangeaisons
- E. Manque du mot**

5. Les caractéristiques principales de la douleur dans l'algie vasculaire de la face sont :

- A. Douleur modérée et diffuse
- B. Douleur bilatérale dans tout le crâne
- C. Douleur très intense, autour de l'œil
- D. Douleur liée à une vasoconstriction
- E. Douleur ayant une intensité extrême, maximale en quelques minutes

Les caractéristiques principales de la douleur dans l'algie vasculaire de la face sont :

- A. Douleur modérée et diffuse
- B. Douleur bilatérale dans tout le crâne
- C. Douleur très intense, autour de l'œil**
- D. Douleur liée à une vasoconstriction
- E. Douleur ayant une intensité extrême, maximale en quelques minutes**

6. La durée typique d'une crise d'algie vasculaire de la face

- A. Quelques secondes
- B. Moins de 15 minutes
- C. Entre 15 minutes et 3 heures
- D. Plus de 24 heures
- E. De plus de 72 heures

6. La durée typique d'une crise d'algie vasculaire de la face

- A. Quelques secondes
- B. Moins de 15 minutes
- C. Entre 15 minutes et 3 heures**
- D. Plus de 24 heures
- E. De plus de 72 heures

7. Les symptômes associé à une crise d'algie vasculaire de la face sont :

- A. Gonflement des lèvres
- B. Larmolement et congestion nasale du même côté que la douleur
- C. Engourdissement des mains
- D. Fièvre modérée
- E. syndrome de Claude Bernard Horner

Les symptômes associé à une crise d'algie vasculaire de la face sont :

A. Gonflement des lèvres

B. Larmoiement et congestion nasale du même côté que la douleur

C. Engourdissement des mains

D. Fièvre modérée

E. syndrome de Claude Bernard Horner

8. Les symptômes de la maladie de Horton sont :

- A) Douleurs articulaires
- B) Céphalées pariétales
- C) Éruption cutanée
- D) Une nécrose linguale
- E) scotome central

Les symptômes de la maladie de Horton sont :

A) Douleurs articulaires

B) Céphalées pariétales

C) Éruption cutanée

D) Une nécrose linguale

E) scotome central

9. Quels examens demandés pour confirmer le diagnostic de la maladie d'Horton?

- A) Scanner cérébral
- B) Ponction lombaire
- C) Biopsie de l'artère temporale
- D) Radiographie du crâne
- E) Echo doppler

Quels examens demandés pour confirmer le diagnostic de la maladie d'Horton?

- A) Scanner cérébral
- B) Ponction lombaire
- C) Biopsie de l'artère temporale**
- D) Radiographie du crâne
- E) Echo doppler**

10. Les risques associé à la maladie de Horton sont :

- A) Infarctus du myocarde
- B) Perte de poids
- C) Cécité brutale
- D) Paralysie faciale
- E) un AVC occipital

Les risques associé à la maladie de Horton sont :

A) Infarctus du myocarde

B) Perte de poids

C) Cécité brutale

D) Paralysie faciale

E) un AVC occipital

11. Quel est le traitement de première intention de la maladie de Horton ?

- A) Antibiotiques
- B) AINS
- C) Corticoïdes à forte dose
- D) Immunothérapie ciblée
- E) Aspirine

11. Quel est le traitement de première intention de la maladie de Horton ?

- A) Antibiotiques
- B) AINS
- C) Corticoïdes à forte dose**
- D) Immunothérapie ciblée
- E) Aspirine

12. La branche du nerf trijumeau le plus souvent atteinte dans la névralgie du trijumeau est:

- A) V1 (ophtalmique)
- B) V2 (maxillaire)
- C) V3 (mandibulaire)
- D) V2 et V3
- E) V1 et V3

La branche du nerf trijumeau le plus souvent atteinte dans la névralgie du trijumeau est:

A) V1 (ophtalmique)

B) V2 (maxillaire)

C) V3 (mandibulaire)

D) V2 et V3

E) V1 et V3

13. Les caractéristiques de la douleur dans la névralgie faciale classique est :

- A) Continue, sourde et profonde
- B) Pulsatile, nocturne
- C) Brève, fulgurante et en éclair
- D) Permanente et bilatérale
- E) survient en salves sur quelques minutes séparées par des intervalles libres de toute douleur

13. Les caractéristiques de la douleur dans la névralgie faciale classique est :

- A) Continue, sourde et profonde
- B) Pulsatile, nocturne
- C) Brève, fulgurante et en éclair**
- D) Permanente et bilatérale
- E) survient en salves sur quelques minutes séparées par des intervalles libres de toute douleur**

14. Une zone dite "gâchette" est:

- A) Une zone cutanée qui déclenche une crise
- B) Une zone où on applique un traitement
- C) Une lésion visible sur IRM
- D) Une zone de douleur spontanée
- E) Une zone caractérisée par une hypoesthésie à l'examen neurologique

Une zone dite "gâchette" est:

- A) Une zone cutanée qui déclenche une crise**
- B) Une zone où on applique un traitement
- C) Une lésion visible sur IRM
- D) Une zone de douleur spontanée
- E) Une zone caractérisée par une hypoesthésie à l'examen neurologique

15. Quel facteur peut déclencher une crise de névralgie du trijumeau ?

- A) Le stress uniquement
- B) Le froid, le brossage des dents ou la mastication
- C) L'exercice physique intense
- D) Le sommeil
- E) L'alcool

15. Quel facteur peut déclencher une crise de névralgie du trijumeau ?

A) Le stress uniquement

B) Le froid, le brossage des dents ou la mastication

C) L'exercice physique intense

D) Le sommeil

E) L'alcool

16. La cause la plus fréquente de la névralgie faciale classique est :

- A) Une tumeur
- B) Une infection
- C) Un conflit vasculo-nerveux
- D) Une sclérose en plaques
- E) Un neurinome du V

16. La cause la plus fréquente de la névralgie faciale classique est :

- A) Une tumeur
- B) Une infection
- C) Un conflit vasculo-nerveux**
- D) Une sclérose en plaques
- E) Un neurinome du V